BAİBÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ · HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

Toplum Süreci Çalışma Notu

Toplum Ortaklığı Modeli · Veri Toplama · Toplum Tanısı · Önceliklendirme · Planlama · Uygulama · Değerlendirme

FR.186 Toplum Süreci (20 puan) için: valiliğe bağlı resmi kurumlarda ve özel kuruluşlarda risk belirleme, sağlık eğitimi planlama ve girişimlerin uygulanması adım adım.

İçindekiler

Halk Sağlığı Hemşireliği – Toplum Süreci Çalışma Notu

1. TEMEL KAVRAMLAR

- 1.1 Toplum ve toplum sağlığı hemşireliği
- 1.2 Koruma düzeyleri
- 1.3 Sağlığı geliştirme ve Ottawa Şartı
- 1.4 Sağlığın belirleyicileri
- 1.5 Epidemiyolojik çerçeve

2. HANGİ KURUMLARDA ÇALIŞABİLİRSİN?

3. TOPLUM SÜRECİ ADIM ADIM

- 3.1 Hazırlık ve kuruma giriş
- 3.2 Veri toplama – Toplum Ortaklığı Modeli
- 3.3 Veri analizi ve toplum tanıları
- 3.4 Önceliklendirme
- 3.5 Planlama
- 3.6 Uygulama
- 3.7 Değerlendirme

4. KURUM TÜRLERİNE GÖRE OLASI SORUNLAR VE GİRİŞİMLER

- 4.1 Huzurevi ve yaşlı bakım merkezi
- 4.2 Kreş, anaokulu ve çocuk evleri
- 4.3 Engelli bakım ve rehabilitasyon merkezi
- 4.4 Öğrenci yurdu ve gençlik merkezi
- 4.5 Kadın konukevi
- 4.6 İşyeri ve fabrika
- 4.7 Halk Eğitim Merkezi ve kurs katılımcıları
- 4.8 Kur'an kursu ve yatılı kurslar

5. TOPLUM SÜRECİNDE SAĞLIK EĞİTİMİ PLANLAMA

6. TOPLUM SÜRECİ RAPORU NASIL HAZIRLANIR?

7. ÖRNEK: "Toplum sürecini bir huzurevinde nasıl yürüttün?" – model cevap

8. KENDİNİ TEST ET

Halk Sağlığı Hemşireliği – Toplum Süreci Çalışma Notu

Bu not, FR.186 Saha Çalışması Değerlendirme Formu'ndaki **"Toplum Süreci Değerlendirmesi (20 puan)"** bölümüne hazırlanman için yazıldı. Bu bölüm tek bir maddeden oluşur ama 20 puan değerindedir:

> **Madde 20:** "**Valiliğe bağlı resmi kurum ve özel kuruluşlardaki** sağlık sorunlarına ilişkin **risk belirleme, sağlık eğitimi planlama ve gerekli girişimlerin uygulanması**."

Yani senden bir kurumu (huzurevi, kreş, yurt, fabrika vb.) bir "hasta" gibi ele alıp **hemşirelik sürecini topluma uygulaman** beklenir: verileri topla, kurumun sağlık sorunlarını ve risklerini belirle, bunları önceliklendir, sağlık eğitimi ve diğer girişimleri planla, uygula ve değerlendir. Profesyonel davranışlar puanı da toplum sürecinde ayrıca verilir.

---

1. TEMEL KAVRAMLAR

1.1 Toplum ve toplum sağlığı hemşireliği

Toplum, ortak bir coğrafyayı, ilgiyi, değeri ya da amacı paylaşan ve birbiriyle etkileşim içinde olan insanlar topluluğudur. Üç tür toplumdan söz edilir:

- **Coğrafi toplum:** Mahalle, köy, ilçe.
- **Ortak ilgi (işlevsel) toplumu:** Aynı kurumda yaşayan ya da çalışan kişiler: huzurevi sakinleri, bir fabrikanın çalışanları, yurt öğrencileri, bir okulun öğretmenleri.
- **Sorun toplumu:** Ortak bir sorundan etkilenen kişiler: bir su kaynağının kirlenmesinden etkilenenler.

Toplum sürecinde çalışacağın kurumlar genellikle **ortak ilgi toplumu**dur.

Toplum sağlığı hemşireliğinde danışan yalnızca birey değil; **aile, grup ve toplumun bütünüdür**. Amaç toplumun sağlığını korumak, geliştirmek ve hastalıkları önlemektir. Toplum düzeyinde çalışırken soru "Bu kişinin sorunu ne?" değil, "**Bu toplumun (kurumun) ortak sağlık sorunları ve riskleri neler, nedenleri neler ve toplum olarak nasıl çözülebilir?**" sorusudur.

Halk sağlığı hemşiresinin toplum düzeyindeki rolleri: Bakım verici, eğitici, danışman, **savunucu** (toplumun sağlık haklarını savunma), **vaka yöneticisi**, **koordinatör ve işbirlikçi** (kurum yönetimi, belediye, sağlık kurumları, sivil toplum), **araştırmacı**, **lider** ve **değişim ajanı**.

1.2 Koruma düzeyleri

Toplum düzeyindeki girişimler hangi koruma düzeyine hitap ettiklerine göre sınıflanır:

- **Primordiyal koruma:** Risk faktörlerinin topluma hiç girmemesi (sağlıklı kent planlaması, okul kantini düzenlemeleri, tütün yasakları).
- **Birincil koruma:** Hastalık oluşmadan önce önleme (aşılama, sağlık eğitimi, el hijyeni, güvenli çevre, kaza önleme).
- **İkincil koruma:** Erken tanı ve tedavi (kan basıncı, kan şekeri, kanser taramaları; düşme riski taraması).
- **Üçüncül koruma:** Hastalığın komplikasyonlarını ve sakatlığı sınırlama, rehabilitasyon (diyabetik ayak bakımı, inme sonrası rehabilitasyon, bası yarası bakımı).
- **Dördüncül koruma:** Gereksiz ya da aşırı tıbbi müdahaleden korunma (gereksiz antibiyotik ve tetkik kullanımının önlenmesi).

İyi bir toplum planında **birden fazla koruma düzeyine** yönelik girişim bulunur.

1.3 Sağlığı geliştirme ve Ottawa Şartı

Sağlığı geliştirme, insanların sağlıkları üzerindeki kontrollerini artırmalarını ve sağlıklarını iyileştirmelerini sağlama sürecidir. **Ottawa Sağlığı Geliştirme Şartı (1986)** beş eylem alanı tanımlar:

1. **Sağlıklı kamu politikaları oluşturmak** (kurumun sağlığı destekleyen kurallar koyması: dumansız alan, sağlıklı menü).
2. **Destekleyici çevreler yaratmak** (güvenli bina, yürüyüş alanı, sabunlu lavabo).
3. **Toplum eylemini güçlendirmek** (kurum sakinlerinin ve çalışanlarının sorunları birlikte çözmesi).
4. **Kişisel becerileri geliştirmek** (sağlık eğitimi).

5. **Sağlık hizmetlerini yeniden yönlendirmek** (koruyucu hizmetlere ağırlık verme).

Ve üç strateji önerir: **savunuculuk** (sağlık için savunu yapma), **olanak sağlama/güçlendirme** (insanların kendi sağlıklarını yönetebilmesini sağlama) ve **arabuluculuk** (farklı sektörler arasında işbirliği).

Bu çerçeveyi kullanarak planına yalnızca eğitim değil, çevre düzenlemesi, kurum kuralları ve işbirliği önerileri de eklemelisin.

1.4 Sağlığın belirleyicileri

Bir toplumun sağlığını yalnızca sağlık hizmetleri belirlemez. **Dahlgren ve Whitehead'in modeli** sağlığın belirleyicilerini iç içe katmanlar olarak gösterir: merkezde **yaş, cinsiyet ve kalıtım**; onun çevresinde **bireysel yaşam tarzı** (beslenme, hareket, sigara); sonra **sosyal ve toplumsal ağlar** (aile, arkadaşlar, komşular); sonra **yaşam ve çalışma koşulları** (eğitim, iş ortamı, işsizlik, su ve sanitasyon, sağlık hizmetleri, konut, beslenme ve tarım); en dışta **genel sosyoekonomik, kültürel ve çevresel koşullar**. Kurumdaki sorunların nedenlerini ararken bu katmanların hepsini düşünmelisin.

1.5 Epidemiyolojik çerçeve

- **Epidemiyolojik üçgen:** Bir sağlık sorunu, **konak** (yaş, bağışıklık, davranışlar), **etken** (mikroorganizma, kimyasal, fiziksel etken) ve **çevre** (fiziksel, sosyal, biyolojik çevre) arasındaki etkileşimle ortaya çıkar. Girişim bu üç unsurdan birine ya da birkaçına yönelir.
- **Enfeksiyon zinciri:** Bulaşıcı bir hastalık şu altı halkayla yayılır: **etken → rezervuar (kaynak) → çıkış kapısı → bulaşma yolu → giriş kapısı → duyarlı konak.** Girişimler zincirin bir halkasını kırmayı hedefler: hastanın erken tedavisi kaynağı, maske ve öksürük hijyeni çıkış kapısını, **el hijyeni ve ortam temizliği bulaşma yolunu**, **aşılama duyarlı konağı** hedefler. Kreş, huzurevi, yurt gibi kalabalık kurumlarda bu çerçeve çok işe yarar.

---

2. HANGİ KURUMLARDA ÇALIŞABİLİRSİN?

Valiliğe bağlı resmi kurumlara örnekler:

- Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı **huzurevleri** ve yaşlı bakım-rehabilitasyon merkezleri, **çocuk evleri (sevgi evleri)**, **engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri**, **kadın konukevleri**
- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı **gençlik merkezleri** ve öğrenci yurtları
- **Halk Eğitim Merkezleri** (kurs katılımcıları)
- İl Müftülüğüne bağlı **Kur'an kursları**
- İl/ilçe müdürlükleri ve belediye birimleri (çalışan sağlığı)

Özel kuruluşlara örnekler: Özel kreş ve anaokulları, özel huzurevleri, **fabrika ve işyerleri**, oteller, alışveriş merkezleri, özel yurtlar, dernekler.

---

3. TOPLUM SÜRECİ ADIM ADIM

Toplum sürecini, hemşirelik sürecinin topluma uygulanmış hali olarak düşün:

1. **Hazırlık ve giriş**
2. **Veri toplama (toplumun tanılanması)**
3. **Veri analizi ve toplum tanılarının belirlenmesi**
4. **Önceliklendirme**
5. **Planlama**
6. **Uygulama**
7. **Değerlendirme**
8. **Raporlama**

3.1 Hazırlık ve kuruma giriş

- Öğretim elemanının yönlendirmesiyle kurum belirlenir; **kurum yöneticisinden izin** alınır.
- Yöneticiyle tanışma görüşmesinde çalışmanın amacı, süresi, yapılacak etkinlikler (görüşme, gözlem, anket, tarama, eğitim) ve kurumdan beklenenler anlatılır.
- Kurumda iletişim kurulacak bir **sorumlu kişi** (kurum hemşiresi, sosyal çalışmacı, insan kaynakları sorumlusu) belirlenir.
- **Etik ilkeler** konuşulur: Katılımın gönüllülüğü, kişisel bilgilerin gizliliği, anketlerde kimlik bilgisi alınmaması, fotoğraf için izin ve yüzlerin görünmemesi.
- Çalışma takvimi kurumun işleyişine (yemek saatleri, vardiyalar, ziyaret saatleri) göre yapılır.

3.2 Veri toplama – Toplum Ortaklığı Modeli

Toplumun tanılanmasında en sık kullanılan model **Anderson ve McFarlane'in Toplum Ortaklığı Modeli**dir (Community as Partner). Bu model toplumu bir **çekirdek** ve onu çevreleyen **sekiz alt sistem** olarak ele alır. Kurumda veri toplarken her alt sistem için aşağıdaki soruları sor.

Çekirdek – insanlar

Toplumun kendisini oluşturan insanlar ve özellikleri:

- **Tarihçe:** Kurum ne zaman, hangi amaçla kuruldu? Son yıllarda ne değişti?
- **Demografik özellikler:** Kaç kişi yaşıyor ya da çalışıyor? Yaş ve cinsiyet dağılımı, medeni durum, eğitim düzeyi, meslekler, kurumda kalış/çalışma süresi.
- **Etnik ve kültürel yapı:** Farklı kültürlerden, göçmen kökenli kişiler var mı? Dil engeli var mı?
- **Değerler, inançlar ve din:** Sağlıkla ilgili inançlar, dini uygulamalar (oruç, beslenme kuralları), sağlık hizmeti kullanımını etkileyen değerler.

Sekiz alt sistem

1. Fiziksel çevre: Binanın yaşı ve durumu, odaların büyüklüğü ve kaç kişinin kaldığı (kalabalık), ısınma, havalandırma, aydınlatma, nem ve küf, temizlik, tuvalet ve banyoların sayısı ve durumu, su, atık yönetimi, haşere, mutfak, bahçe ve açık alanlar, gürültü, kurumun çevresi.

2. Sağlık ve sosyal hizmetler: Kurumda sağlık personeli (hekim, hemşire, sosyal çalışmacı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog) var mı? Revir var mı? Bağlı olduğu ASM hangisi, ne sıklıkla geliyor? Kayıtlarda en sık hangi sağlık sorunları var (kronik hastalıklar, enfeksiyonlar, kazalar, düşmeler)? Aşılama durumu (grip, pnömokok, Td)? İlaçlar nasıl saklanıyor ve dağıtılıyor? Sosyal hizmet ve psikolojik destek olanakları?

3. Ekonomi: Kurumun bütçesi ve kaynakları; sakinlerin ya da çalışanların gelir düzeyi, sosyal güvencesi; çalışanların ücret ve çalışma koşulları; ekonomik güçlüklerin sağlığa etkisi.

4. Ulaşım ve güvenlik: Kuruma ulaşım ve kurumun sağlık kurumlarına uzaklığı; acil durumda ambulans erişimi; **yangın güvenliği** (söndürücüler, acil çıkışlar, tahliye planı, tatbikat); deprem güvenliği; kurum güvenliği (güvenlik görevlisi, giriş-çıkış denetimi); iş kazaları; **düşme ve yaralanma riskleri**.

5. Politika ve yönetim: Kurumun yönetim yapısı, kararların nasıl alındığı, kurumun kuralları (sigara içme, ziyaret, yemek saatleri), sağlıkla ilgili politikalar (enfeksiyon kontrolü, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları), sakinlerin ve çalışanların karar süreçlerine katılımı.

6. İletişim: Kurum içinde resmi iletişim kanalları (duyuru panoları, toplantılar, yazılı duyurular, mesaj grupları) ve resmi olmayan iletişim (sohbet ortamları, sözü dinlenen kişiler); sakinlerin aileleriyle ve dış dünyayla iletişimi; bilgiye ulaşma yolları. **Bu alt sistem eğitimin nasıl duyurulacağını belirlemek için önemlidir.**

7. Eğitim: Sakinlerin ve çalışanların eğitim düzeyi, okuryazarlık; kurumda daha önce yapılmış sağlık eğitimleri; hizmet içi eğitimler (çalışanlar ilk yardım, enfeksiyon kontrolü, düşme önleme konusunda eğitim almış mı?); eğitim için uygun alanlar (salon, projeksiyon).

8. Rekreasyon: Boş zaman etkinlikleri, sosyal etkinlikler, spor ve hareket olanakları, hobi atölyeleri, bahçe, ortak yaşam alanları; sakinlerin günlük yaşamının ne kadarı hareketsiz geçiyor?

Bu model ayrıca toplumu etkileyen **stresörleri** (sorunlara yol açan etkenler) ve toplumun bunlara karşı **savunma ve direnç kaynaklarını** (güçlü yönler) tanımlamayı önerir. Örneğin bir huzurevinde personel yetersizliği bir stresör, sakinler arasındaki dayanışma ise bir güçlü yöndür.

Ön cam (windshield) taraması

Kurumu ve çevresini, bir arabanın ön camından bakar gibi **yürüyerek ve gözlemleyerek** sistematik biçimde incelemektir. Gözlemlenenler: binanın ve çevresinin durumu; insanların görünümü ve ne yaptıkları (dinlenen, sigara içen, yürüyen, yalnız oturan); toplanma alanları; temizlik ve atıklar; güvenlik sorunları; ulaşım; duyuru panoları ve iletişim araçları; sağlık-hastalık göstergeleri (tekerlekli sandalye kullanan, baston kullanan kişiler, öksüren kişiler). Ön cam taraması ilk izlenimi verir ve diğer veri toplama yöntemlerini yönlendirir.

Veri toplama yöntemleri

- **Gözlem:** Kontrol listesi kullanılarak (fiziksel çevre, hijyen, güvenlik, beslenme, etkinlikler).
- **Kilit kişi görüşmesi:** Kurum müdürü, kurum hemşiresi, sosyal çalışmacı, aşçı, bakım personeli, kurumda uzun süredir bulunan sakinler gibi kurumu iyi tanıyan kişilerle yarı yapılandırılmış görüşmeler.
- **Odak grup görüşmesi:** 6–10 kişilik bir grupla (örneğin sakinler ya da çalışanlar) belirli bir konuda (sağlık sorunları, gereksinimler) yönlendirilmiş grup tartışması.
- **Anket:** Sağlık sorunları, yaşam tarzı, bilgi düzeyi, eğitim gereksinimleri hakkında kısa, anlaşılır, kimlik bilgisi içermeyen sorular.
- **Ölçüm ve taramalar:** Kan basıncı, kan şekeri, boy-kilo-BKİ, düşme riski testleri (Kalk ve Yürü), görme, ölçekler (günlük yaşam aktiviteleri, depresyon).

- **İkincil veriler:** Kurum kayıtları (revir defteri, kaza-düşme kayıtları, ilaç listeleri, menüler, devamsızlık ya da raporlu gün sayıları), ilçe sağlık müdürlüğü ve TÜİK verileri.

Farklı yöntemleri birlikte kullanmak verinin güvenilirliğini artırır: örneğin yöneticinin "düşme sorunumuz yok" demesi ile kayıtlarda son altı ayda on dört düşme olması arasındaki fark ancak böyle ortaya çıkar.

3.3 Veri analizi ve toplum tanıları

Toplanan veriler alt sistemlere göre özetlenir, **sayısal göstergelere** dönüştürülür (yüzde, sayı) ve birbiriyle ilişkili veriler bir araya getirilerek **sorunlar ve riskler** belirlenir. Ardından her biri için bir **toplum tanısı** yazılır.

Toplum tanısı nasıl yazılır?

Toplum tanısı üç bölümden oluşur:

> **[Hangi toplumda/grupta] [hangi sorun ya da risk]; [nedenleri/ilişkili etkenler] ile ilişkili; [sayısal göstergeler/veriler] ile kendini gösteren.**

Bu yapı bireysel NANDA tanısına benzer: sorun, etiyoloji ve kanıt. Toplum tanısında **mutlaka sayısal göstergeler** bulunmalıdır; çünkü değerlendirme aşamasında bu göstergelerin değişip değişmediğine bakacaksın.

Örnek toplum tanıları

1. **Huzurevinde kalan yaşlılarda düşme riski**; ortak alanlarda kaygan zemin, koridorlarda yetersiz gece aydınlatması, banyolarda tutunma barı olmaması, sakinlerin önemli bir kısmının çok sayıda ilaç kullanması ve bakım personelinin düşmeyi önleme konusunda eğitim almamış olması ile ilişkili; son 6 ayda kayıtlarda 14 düşme olayı bulunması, değerlendirilen 40 sakinin 17'sinde (%42,5) Kalk ve Yürü testinin 14 saniye ve üzerinde olması ve sakinlerin %60'ının 5 ve daha fazla ilaç kullanması ile kendini gösteren.
2. **Kreşteki 3–6 yaş çocuklarda bulaşıcı hastalık riski**; lavabolarda sabun bulunmaması, çocukların el yıkama becerisinin yetersiz olması ve oyuncakların düzenli temizlenmemesi ile ilişkili; son bir ayda 9 çocuğun ishal nedeniyle devamsızlık yapması ve gözlemde çocukların yalnızca %20'sinin yemekten önce elini yıkaması ile kendini gösteren.
3. **Fabrika çalışanlarında kas-iskelet sistemi sorunları**; ergonomik olmayan çalışma istasyonları, ağır yüklerin elle taşınması, mola sürelerinin yetersizliği ve doğru kaldırma tekniği konusunda eğitim eksikliği ile ilişkili; anket yapılan 60 çalışanın 34'ünün (%57) son bir yılda bel ağrısı bildirmesi ve son bir yılda bel ağrısı nedeniyle 11 raporlu iş günü kaybı kaydı ile kendini gösteren.
4. **Öğrenci yurdunda kalan gençlerde sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam**; yurt menüsünde sebze-meyvenin az olması, kantinde hazır atıştırmalıkların yaygınlığı, spor alanının bulunmaması ve öğrencilerin uzun süre ekran başında kalması ile ilişkili; ankete katılan öğrencilerin %48'inin kahvaltıyı atladığını, %35'inin BKİ'sinin 25 ve üzerinde olduğunu ve %70'inin haftada 150 dakikadan az fiziksel aktivite yaptığını belirtmesi ile kendini gösteren.
5. **Kur'an kursunda yatılı kalan öğrencilerde pediküloz ve uyuz riski**; kalabalık yatakhaneler, havlu ve tarak gibi kişisel eşyaların paylaşılması ve kişisel hijyen konusunda bilgi eksikliği ile ilişkili; taramada 45 öğrencinin 8'inde (%17,8) bit ya da sirke saptanması ve son iki ayda 3 uyuz olgusu kaydı ile kendini gösteren.

> NANDA-I'da toplum düzeyinde "**Toplum sağlığında yetersizlik**", "**Etkisiz toplum baş etmesi**" ve "Toplum baş etmesini geliştirmeye hazır oluş" tanıları da kullanılabilir. Omaha'da toplum düzeyindeki sorunlar **kapsam: Toplum** niteleyicisiyle kaydedilir.

Kurumun **güçlü yönlerini** de yaz (ilgili ve işbirliğine açık yönetim, deneyimli personel, sakinler arasında dayanışma, eğitim salonu olması); bunlar girişimlerde kaynak olarak kullanılır.

3.4 Önceliklendirme

Genellikle birden fazla sorun saptarsın; hepsiyle aynı anda çalışamazsın. Sorunları **önceliklendirmek** için şu ölçütler kullanılır ve her sorun için puanlanır (örneğin her ölçüt için 1 = düşük, 2 = orta, 3 = yüksek):

1. **Toplumun sorunun farkında olması:** Kurum yönetimi ve sakinler bu sorunu bir sorun olarak görüyor mu?
2. **Toplumun sorunu çözme isteği (motivasyonu):** Çözüm için çaba göstermeye istekliler mi?
3. **Hemşirenin sorunun çözümünü etkileme gücü:** Hemşirelik girişimleriyle (eğitim, savunuculuk, yönlendirme) bu sorun üzerinde etkili olunabilir mi?
4. **Çözüm için uzman ve kaynak bulunabilirliği:** Gerekli kaynaklar (uzman, malzeme, bütçe) var mı?
5. **Sorun çözülmezse sonuçların ciddiyeti:** Ölüm, sakatlık, yaygın hastalık riski var mı?
6. **Çözümün hızı:** Sonuç ne kadar sürede alınabilir?

Her sorunun puanları toplanır; **en yüksek puanlı sorun ilk önceliği** alır. Önceliklendirme sırasında kurum yönetiminin ve sakinlerin/çalışanların görüşünü almak, onların sürece katılmasını sağlar (Ottawa'nın "toplum eylemini güçlendirme" ilkesi).

Örnek: Huzurevinde "düşme riski" için farkındalık 3 (yönetim düşmelerden endişeli), istek 3, hemşirenin etkileme gücü 3 (eğitim ve çevre önerileri yapılabilir), kaynak 2 (tutunma barları için bütçe sınırlı), ciddiyet 3 (kalça kırığı ve ölüm riski), hız 2 → toplam 16. "Sakinlerde hareketsizlik" için toplam 13 olabilir. Bu durumda düşme riski birinci öncelik olur; hareketsizlik ise düşme önleme programındaki egzersiz bileşeniyle birlikte ele alınabilir.

> Alternatif olarak Hanlon yöntemi gibi daha ayrıntılı önceliklendirme yöntemleri de vardır; sorunun büyüklüğü, ciddiyeti ve müdahalenin etkililiği puanlanarak öncelik belirlenir. Öğrenci projelerinde yukarıdaki basit puanlama genellikle yeterlidir.

3.5 Planlama

Öncelikli her sorun için bir **plan** yapılır. Planın bileşenleri:

- **Amaç:** Genel olarak ulaşılmak istenen durum.
- **Hedefler:** Ölçülebilir, zaman sınırlı, kimi ve neyi kapsadığı belli ifadeler. Bilgi, davranış, çevre ve sağlık sonucu düzeylerinde hedefler yazılabilir.
- **Hedef kitle:** Kimlere yönelik? (sakinler, çalışanlar, aileler, yönetim)
- **Faaliyetler (girişimler):** Eğitimler, taramalar, çevre düzenlemesi önerileri, kurum politikası önerileri, yönlendirmeler, işbirlikleri.
- **Yöntem ve materyal.**
- **Sorumlular:** Her faaliyeti kim yapacak? (öğrenci hemşire, kurum hemşiresi, yönetim, teknik personel)
- **Zaman çizelgesi.**
- **Kaynaklar:** Salon, projeksiyon, maket, malzeme, bütçe.
- **Değerlendirme göstergeleri:** Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı neye bakılarak anlaşılacak?

Örnek plan – Huzurevinde düşme riski

- **Amaç:** Huzurevinde düşme olaylarını azaltmak.
- **Hedefler:**

1. Eğitime katılan bakım personelinin en az %80'i, eğitimin sonunda düşme risk faktörlerinden en az beşini sayabilecek.
2. Eğitime katılan sakinlerin en az %70'i, eğitimin sonunda yataktan güvenli kalkma basamaklarını gösterebilecek.
3. Bir ay içinde koridorlara gece aydınlatması, banyolara kaydırmaz paspas ve tutunma barı konmuş olacak (yönetimle işbirliği).
4. Haftada iki gün denge ve kuvvet egzersiz grubu başlatılmış ve en az 15 sakin düzenli katılıyor olacak.
5. Üç ay sonunda aylık ortalama düşme sayısı azalmış olacak (kurumun izlemesi için önerilir).

- **Faaliyetler:**
  - Sakinlere grup eğitimi: düşmelerin nedenleri, yataktan yavaş ve güvenli kalkma, uygun ayakkabı ve terlik, gözlük kullanımı, gece tuvalete giderken ışık açma, düştüğünde yardım isteme (gösterip yaptırma ile).
  - Bakım personeline eğitim: düşme risk değerlendirmesi, Kalk ve Yürü testi, ortostatik hipotansiyon, güvenli transfer teknikleri, düşme sonrası yapılacaklar, düşme kayıt formunun kullanımı.
  - Denge ve kuvvet egzersiz grubunun başlatılması (sandalye egzersizleri; fizyoterapistle işbirliği varsa onunla).
  - Yönetime yazılı rapor ve öneriler: ortam düzenlemeleri, ilaçların kurum hekimi tarafından gözden geçirilmesi, düşme kayıt sisteminin kurulması.
  - Yüksek riskli sakinlerin kurum hekimine bildirilmesi.
- **Yöntem ve materyal:** Anlatım, gösterip yaptırma, soru-cevap; büyük puntolu broşür, poster, egzersiz kartları.
- **Sorumlular:** Öğrenci hemşireler (eğitimler, egzersiz grubunun başlatılması), kurum hemşiresi (sürdürme, kayıt), yönetim (çevre düzenlemeleri), kurum hekimi (ilaç gözden geçirme).
- **Zaman çizelgesi:** 1. hafta veri toplama ve önceliklendirme; 2. hafta eğitimler; 3. hafta egzersiz grubu ve çevre düzenlemelerinin takibi; 4. hafta değerlendirme ve rapor.
- **Değerlendirme göstergeleri:** Ön-son test puanları; geri gösterim kontrol listesi sonuçları; egzersiz grubuna katılım sayısı; çevre düzenlemelerinin yapılıp yapılmadığı; aylık düşme sayısı.

3.6 Uygulama

- Planlanan eğitimler ve girişimler yapılır. Her eğitim için ayrı bir **eğitim planı** hazırlanır (konu, hedef kitle, hedefler, içerik, yöntem, materyal, süre, değerlendirme).
- Eğitimlerin duyurulmasında kurumun **iletişim kanalları** kullanılır (duyuru panosu, yöneticinin duyurusu, sözü dinlenen sakinler).
- Eğitimlerin zamanı kurumun işleyişine uygun seçilir (yemek ve ilaç saatleri dışında, vardiya değişimlerine göre).
- **Kayıt:** Katılımcı sayısı, eğitim planı, materyal, izinli fotoğraf (yüzler görünmeden), ön-son test sonuçları, **Omaha kaydı** (kapsam: Toplum).
- Kurum yönetimine **yazılı rapor ve öneriler** sunulur; önerilerde mümkün olduğunca **sorumlu ve süre** belirtilir.

3.7 Değerlendirme

Toplum düzeyinde değerlendirme üç düzeyde yapılır:

- **Süreç değerlendirmesi:** Planlanan faaliyetler **yapıldı mı, nasıl yapıldı?** Kaç eğitim yapıldı, kaç kişi katıldı, materyaller kullanıldı mı, zaman çizelgesine uyuldu mu, katılımcılar memnun mu? *Örnek:* "Üç eğitim yapıldı; 32 sakin ve 12 bakım personeli katıldı; egzersiz grubu iki kez toplandı."
- **Etki değerlendirmesi:** Eğitim ve girişimler sonucunda **bilgi, tutum, davranış ve çevrede** değişiklik oldu mu? *Örnek:* "Personelin ön test ortalaması 52'den son testte 86'ya yükseldi; sakinlerin %75'i güvenli kalkma basamaklarını doğru gösterdi; banyolara kaydırmaz paspas kondu, koridor aydınlatması yapıldı."

- **Sonuç değerlendirmesi:** Uzun vadede **sağlık göstergeleri** değişti mi? *Örnek:* "Üç ay sonra aylık düşme sayısının azalması beklenir; kurumun düşme kayıtlarını izleyerek bu değişikliği değerlendirmesi önerildi."

Öğrenci olarak sürenin kısa olması nedeniyle genellikle süreç ve etki değerlendirmesini yapabilirsin; sonuç değerlendirmesi için kuruma **izlenecek göstergeleri** önerirsin.

Hedeflere ulaşılamayan noktalar için nedenler analiz edilir ve **yeniden planlama** yapılır; kurumun girişimleri sürdürebilmesi için öneriler (sorumlu kişi, düzenli eğitim, kayıt sistemi) yazılır.

---

4. KURUM TÜRLERİNE GÖRE OLASI SORUNLAR VE GİRİŞİMLER

4.1 Huzurevi ve yaşlı bakım merkezi

Olası sorunlar ve riskler: Düşmeler ve kırıklar; bası yaraları (yatağa bağımlı sakinlerde); malnütrisyon ve dehidratasyon; enfeksiyonlar (grip, solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, uyuz, ishal salgınları); çok ilaç kullanımı ve ilaç hataları; depresyon, yalnızlık, yas; demans ve davranış sorunları; idrar kaçırma; görme-işitme kaybı; sıcak çarpması; yangın ve tahliye güçlüğü; bakım personelinde bel ağrısı ve tükenmişlik. **Girişimler:** Düşme önleme programı (eğitim, egzersiz, çevre düzenlemesi); el hijyeni ve enfeksiyon kontrolü eğitimi (sakin ve personel); grip ve pnömokok aşılarının durumunun kontrolü ve yönlendirme; sıvı alımı programı (düzenli su ikramı, sıvı takip çizelgesi); beslenme değerlendirmesi ve menü önerileri; bası yarası risk değerlendirmesi ve önleme (pozisyon değiştirme, cilt bakımı); bilişsel uyarım ve sosyal etkinlikler; ilaçların güvenli saklanması ve dağıtımı; personele transfer teknikleri ve ergonomi eğitimi; bakım veren stres yönetimi.

4.2 Kreş, anaokulu ve çocuk evleri

Olası sorunlar: Bulaşıcı hastalıklar (ishal, el-ayak-ağız hastalığı, grip, suçiçeği, pediküloz); kazalar (düşme, yabancı cisim aspirasyonu, zehirlenme, yanık, sıkışma); yetersiz ya da dengesiz beslenme, obezite; aşı eksikliği; diş çürükleri; ihmal ve istismar riski; personelin el hijyeni ve gıda hijyeni. **Girişimler:** Çocuklara el yıkama ve diş fırçalama alışkanlığı (oyun ve şarkıyla); personele el hijyeni, oyuncak ve ortam temizliği, bez değiştirme hijyeni eğitimi; çocuklarda boğulma durumunda ilk yardım (çocuk ve bebekte Heimlich manevrası) eğitimi; ev ve kurum kazalarını önleme; menüye yönelik sağlıklı beslenme önerileri; aşı kartlarının kontrolü ve ASM'ye yönlendirme; büyüme taraması (boy-kilo); yaşa uygun kişisel güvenlik eğitimi; bulaşıcı hastalıkta çocuğun kurumdan uzak kalma kuralları.

4.3 Engelli bakım ve rehabilitasyon merkezi

Olası sorunlar: Bası yaraları, aspirasyon (yutma güçlüğü), kontraktürler, kabızlık, idrar yolu enfeksiyonları, epileptik nöbetler, ağız-diş sorunları, bakım verenlerde tükenmişlik ve bel ağrısı. **Girişimler:** Pozisyon verme ve cilt bakımı; güvenli besleme teknikleri; nöbet sırasında ilk yardım; ağız bakımı; personele ergonomi ve transfer eğitimi; bakım veren stres yönetimi.

4.4 Öğrenci yurdu ve gençlik merkezi

Olası sorunlar: Kahvaltı atlama ve sağlıksız beslenme; düzensiz uyku; hareketsiz yaşam ve uzun ekran süresi; sigara, elektronik sigara, alkol ve madde kullanımı; stres, sınav kaygısı, yalnızlık, depresyon; cinsel sağlık ve üreme sağlığı bilgi eksikliği; bulaşıcı hastalıklar (uyuz, grip, menenjit, tüberküloz riski kalabalık yatakhanelerde); yangın güvenliği. **Girişimler:** Sağlıklı beslenme ve uyku hijyeni eğitimleri; stres yönetimi ve sınav kaygısıyla baş etme; madde kullanımını önleme ve akran baskısına hayır deme; cinsel sağlık ve üreme sağlığı (kurum onayıyla, uygun yöntemle); KKMM ve testis kendi muayenesi; aşı durumu ve el hijyeni; ruhsal destek kaynaklarına yönlendirme; yangın güvenliği.

4.5 Kadın konukevi

Olası sorunlar: Travma ve ruh sağlığı sorunları; gebelik ve üreme sağlığı gereksinimleri; çocukların izlem ve aşı eksiklikleri; kronik hastalıkların izlenememesi; kanser taramalarının yapılmamış olması. **Girişimler:** Güvenli, yargılamayan ve güçlendirici yaklaşım; üreme sağlığı ve aile planlaması danışmanlığı; kanser taramalarına yönlendirme; ASM'ye kayıt ve bağlanma; çocukların izlem ve aşılarının kontrolü; stresle baş etme. (Gizlilik ve güvenlik bu kurumlarda özellikle önemlidir; fotoğraf ve kimlik bilgisi konusunda çok dikkatli olunmalıdır.)

4.6 İşyeri ve fabrika

Olası sorunlar: İşyerindeki tehlikeler beş grupta düşünülür:

- **Fiziksel:** Gürültü (uzun süreli yüksek gürültü işitme kaybına yol açar), titreşim, aşırı sıcak ya da soğuk, yetersiz aydınlatma, toz, radyasyon.
- **Kimyasal:** Solventler, boyalar, temizlik kimyasalları, metal tozları, gazlar.
- **Biyolojik:** Enfeksiyon etkenleri (sağlık, gıda, atık sektörleri).
- **Ergonomik:** Ağır yük kaldırma, tekrarlayan hareketler, uzun süre ayakta ya da oturarak çalışma, uygun olmayan çalışma yüksekliği.
- **Psikososyal:** Yoğun iş yükü, vardiyalı ve gece çalışma, iş güvencesizliği, mobbing, stres. Ayrıca iş kazaları, kronik hastalıklar (hipertansiyon, diyabet, obezite), sigara kullanımı ve hareketsiz yaşam.

Bilmen gereken yasal çerçeve: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işveren, işyerinde **risk değerlendirmesi yapmak ya da yaptırmak** zorundadır; işyerleri **az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli** olarak sınıflanır; işyerlerinde **işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı** ve gerekli durumlarda **diğer sağlık personeli** (hemşire) görevlendirilir; çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi zorunludur; işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapılır.

Girişimler: Kişisel koruyucu donanımların (kulak koruyucu, maske, gözlük, eldiven, iş ayakkabısı) doğru kullanımı; doğru yük kaldırma tekniği ve egzersizler; kan basıncı, kan şekeri, BKİ taraması; sigara bırakma; stres yönetimi; vardiyalı çalışanlarda uyku hijyeni; iş kazalarında ilk yardım; kanser taramalarına yönlendirme. Kişisel koruyucu donanımın, risk kontrol hiyerarşisinde **en son basamak** olduğu; önce tehlikenin kaynağında azaltılması gerektiği (makine koruyucusu, gürültü yalıtımı, havalandırma, ergonomik düzenleme) yönetime önerilir.

4.7 Halk Eğitim Merkezi ve kurs katılımcıları

Olası sorunlar: Kronik hastalıklar (hipertansiyon, diyabet, obezite), kanser taramalarına düşük katılım, sağlıksız beslenme, sigara, aile planlaması gereksinimleri. **Girişimler:** Kanser tarama eğitimi (KKMM, GGT, HPV) ve yönlendirme; hipertansiyon ve diyabet eğitimi, kan basıncı ve kan şekeri taraması; sağlıklı beslenme ve tuz kısıtlaması; aile planlaması; sigara bırakma.

4.8 Kur'an kursu ve yatılı kurslar

Olası sorunlar: Pediküloz ve uyuz, ishal, kalabalık yatakhanelerde solunum yolu enfeksiyonları, yetersiz beslenme, ağız-diş sorunları, kişisel eşyaların ortak kullanımı. **Girişimler:** Pediküloz ve uyuz taraması ve eğitimi; el hijyeni; kişisel eşyaların paylaşılmaması; diş fırçalama; sağlıklı beslenme ve menü önerileri; yatakhanelerin havalandırılması; yöneticilere bulaşıcı hastalıklarda yapılacaklar konusunda bilgilendirme.

---

5. TOPLUM SÜRECİNDE SAĞLIK EĞİTİMİ PLANLAMA

Formdaki madde "**sağlık eğitimi planlama**" ifadesini özellikle içerir. Kurumdaki her eğitim için:

- **Gereksinimi verilerle göster:** "Ankete katılan çalışanların %57'si bel ağrısı bildirdi; bu nedenle doğru kaldırma tekniği eğitimi planlandı."
- **Hedef kitleyi ve özelliklerini yaz:** Yaş, eğitim düzeyi, okuryazarlık, çalışma saatleri, dil.
- **Ölçülebilir hedefler yaz:** "Eğitim sonunda katılımcıların en az %80'i doğru kaldırma tekniğini uygulamalı olarak gösterir."
- **Yöntem ve materyali hedef kitleye göre seç:** Yaşlılar için kısa, büyük puntolu, gösterip yaptırmalı; çalışanlar için kısa ve işe özgü; çocuklar için oyunlu.
- **Zamanı ve süreyi kurumun işleyişine göre belirle:** Vardiya değişimi, öğle arası, etkinlik saatleri; yetişkin gruplarında 20–30 dakika.
- **Değerlendirmeyi planla:** Ön-son test, geri gösterim, gözlem.
- **Omaha ile kaydet:** Kapsam **Toplum**.

---

6. TOPLUM SÜRECİ RAPORU NASIL HAZIRLANIR?

1. **Giriş:** Kurumun adı (kodlanabilir), türü, bağlı olduğu birim, kuruluş amacı ve hizmet verdiği kişiler.
2. **Yöntem:** Kullanılan model (Toplum Ortaklığı Modeli), veri toplama yöntemleri (gözlem, kilit kişi görüşmesi, anket, tarama, kayıt incelemesi) ve tarihleri; etik izinler.
3. **Bulgular (Toplum Ortaklığı Modeline göre):**
   - Çekirdek: kişi sayısı, yaş-cinsiyet dağılımı, eğitim düzeyi, değerler-inançlar
   - Sekiz alt sistem: fiziksel çevre, sağlık ve sosyal hizmetler, ekonomi, ulaşım ve güvenlik, politika ve yönetim, iletişim, eğitim, rekreasyon
   - Stresörler ve güçlü yönler
4. **Saptanan sorunlar ve riskler** (sayısal göstergelerle).
5. **Toplum tanıları** ve **önceliklendirme** (her ölçütün puanı ve toplam).
6. **Plan:** Öncelikli tanılar için amaç, hedefler, faaliyetler, yöntem ve materyal, sorumlular, zaman çizelgesi, kaynaklar ve değerlendirme göstergeleri.
7. **Uygulama:** Yapılan eğitimler (konu, tarih, katılımcı sayısı), taramalar, yönlendirmeler, kuruma sunulan öneriler; Omaha kayıtları.
8. **Değerlendirme:** Süreç, etki ve (öngörülen) sonuç değerlendirmesi; ön-son test sonuçları; hedeflere ulaşma durumu; yeniden planlama.
9. **Kuruma öneriler:** Sürdürülebilirlik için (sorumlu kişi, düzenli eğitim, kayıt sistemi, işbirlikleri).
10. **Sonuç** ve **ekler:** Gözlem kontrol listesi, anket formu, eğitim planları, broşürler, izinli fotoğraflar.

---

7. ÖRNEK: "Toplum sürecini bir huzurevinde nasıl yürüttün?" – model cevap

> "Öncelikle öğretim elemanımız aracılığıyla huzurevi müdüründen izin aldık ve çalışmanın amacını anlattık. Toplum Ortaklığı Modelini kullanarak veri topladık: Kurumda 64 sakin olduğunu, ortalama yaşın 78, sakinlerin %60'ının kadın olduğunu öğrendik. Fiziksel çevreyi kontrol listesiyle gezerek gözlemledik; koridorlarda gece aydınlatması olmadığını, banyolarda tutunma barı ve kaydırmaz paspas bulunmadığını gördük. Kurum hemşiresi ve müdürle kilit kişi görüşmesi yaptık, düşme ve revir kayıtlarını inceledik: son altı ayda 14 düşme kaydı vardı. Gönüllü 40 sakine Kalk ve Yürü testi uyguladık; 17'sinde süre 14 saniyenin üzerindeydi. Sakinlerin çoğunun beş ve daha fazla ilaç kullandığını ve personelin düşme önleme eğitimi almadığını öğrendik. Bu verilerle 'Huzurevinde kalan yaşlılarda düşme riski' toplum tanısını yazdık; ikinci olarak hareketsizlik ve sosyal izolasyon sorununu belirledik. Önceliklendirme ölçütlerine göre düşme riskini birinci öncelik olarak seçtik. Plan kapsamında sakinlere düşmeyi önleme ve güvenli kalkma eğitimi verdik, personele risk değerlendirmesi ve güvenli transfer eğitimi verdik, haftada iki gün sandalye egzersiz grubu başlattık ve yönetime ortam düzenlemeleri ile ilaçların kurum hekimince gözden geçirilmesi için yazılı öneriler sunduk. Eğitimleri ön test ve son testle değerlendirdik: personelin ortalaması 52'den 86'ya yükseldi; sakinlerin %75'i güvenli kalkmayı doğru gösterdi. Yönetim banyolara kaydırmaz paspas koydu. Uzun vadede düşme sayısının izlenmesini ve egzersiz grubunun kurum hemşiresi tarafından sürdürülmesini önerdik. Tüm eğitimleri Omaha sistemiyle, kapsamı 'toplum' olarak kaydettik."

8. KENDİNİ TEST ET

1. Toplum türleri nelerdir? Toplum sürecinde çalıştığın kurum hangi türe girer?
2. Toplum sağlığı hemşiresinin rollerini say.
3. Koruma düzeylerini birer kurum örneğiyle açıkla.
4. Ottawa Şartı'nın beş eylem alanı ve üç stratejisi nelerdir?
5. Dahlgren ve Whitehead modelinin katmanlarını sırala.
6. Enfeksiyon zincirinin halkalarını say. El hijyeni ve aşılama hangi halkaları kırar?
7. Toplum Ortaklığı Modelinin çekirdeği ve sekiz alt sistemi nelerdir? Her alt sistem için bir kurumda soracağın iki soru yaz.
8. Ön cam taraması nedir, neleri gözlemlersin?
9. Kilit kişi görüşmesi ve odak grup görüşmesi arasındaki fark nedir?
10. Toplum tanısının üç bölümü nedir? Bir kreş için sayısal göstergeli bir toplum tanısı yaz.
11. Toplum tanılarını önceliklendirmede kullanılan altı ölçüt nedir?
12. Bir toplum planının bileşenleri nelerdir? Öğrenci yurdu için ölçülebilir iki hedef yaz.
13. Süreç, etki ve sonuç değerlendirmesi arasındaki fark nedir? Birer örnek ver.
14. Bir işyerindeki tehlikeleri hangi beş grupta değerlendirirsin? 6331 sayılı Kanun işverene hangi yükümlülükleri getirir?
15. Huzurevinde hangi sorunlarla karşılaşabilirsin ve hangi girişimleri planlarsın?
16. Toplum sürecinde Omaha kaydında kapsam niteleyicisi nedir?